AutaMedica IA

Historia Clínica Digital con Inteligencia Artificial

CASO CLÍNICO SIMULADO — DEMOSTRACIÓN PEDIÁTRICA

Historia Clínica del Paciente

Paciente simulado | Masculino | ~3 años **Informante:** Madre, 22 años (secundaria incompleta) **Fecha:** 2026-03-28 | **Motor:** Desarrollo interno AutaMedica

---

Motivo de Consulta

> **Fiebre y tos** — 4 días de evolución

Enfermedad Actual

Informante (madre) refiere cuadro de 4 días de evolución caracterizado por fiebre y tos.

> **SEMIOLOGÍA (ALICIADO):** La fiebre es intermitente, con picos nocturnos de hasta 38.7°C medidos con termómetro, con recuerdo materno impreciso de "39 y pico". La tos es referida como "profunda", "que le sale de adentro". Se asocia dificultad respiratoria, con taquipnea referida por la madre ("respira como rápido a veces") y **tiraje intercostal observado por familiar** ("se le mueven las costillitas para adentro").
>
> La fiebre cede parcialmente con ibuprofeno. La tos exacerba la dificultad respiratoria. El decúbito nocturno parece agravar los síntomas respiratorios.

NEGATIVOS PERTINENTES: Niega cianosis ("azul no, eso no"). Niega fonofobia. No se interrogaron: aleteo nasal, quejido espiratorio, signos de deshidratación (lágrimas, mucosas, turgencia).

EVOLUCIÓN: Progresiva, con aparición de letargia ("está caído, no quiere jugar") e inapetencia marcada para sólidos, con ingesta de líquidos conservada. Un episodio de vómito aislado atribuido por la madre a un acceso de tos.

TRATAMIENTO POR CUIDADOR: Ibuprofeno pediátrico en dosis incierta ("como 3 mililitros creo") cada 6-8 horas. Se desestimó consejo de vecina de administrar amoxicilina sobrante. Se intentó miel con limón sin aceptación.

Parámetro	Detalle
Cronología	4 días, inicio insidioso, progresivo
Picos febriles	38.7°C confirmado, ~39°C referido con imprecisión

Síntomas asociados	Taquipnea, tiraje intercostal, letargia, inapetencia, vómito (1 episodio)
Agravantes	Accesos de tos, decúbito nocturno
Contacto epidemiológico	3-4 niños enfermos en guardería + hermano de 1 año con catarro

CASO CLÍNICO SIMULADO — DEMOSTRACIÓN PEDIÁTRICA

Antecedentes

Personales

- **Bronquiolitis** a los 6 meses — internado 3 días
- **Otitis recurrente** — 3 episodios en el último año
- Nacimiento: 37 sem, parto vaginal, 2800g, sin complicaciones
- **Vacunación incompleta** — madre no precisa cuáles faltan, última vacuna "hace bastante"

Medicación actual

Medicamento	Dosis	Frecuencia	Alerta
Ibuprofeno pediátrico	~3 ml (concentración desconocida)	c/6-8 hs	Dosis incierta, sin supervisión médica

Alergias

- No conocidas

Antecedentes familiares

- Padre: posiblemente asmático (madre refiere sin certeza, padre ausente)
- Madre: anemia referida
- Abuela materna: diabetes (referida sin certeza)
- Abuela paterna: hipertensión arterial
- Hermano de 1 año: actualmente con catarro

Entorno y hábitos

- Vivienda con **humedad** en la habitación donde duerme
- **Tabaquismo pasivo** — abuela fuma dentro del hogar
- Colecho (duerme con madre y abuela)
- Alimentación: predominio de leche (3-4 mamaderas/día), rechazo de verduras
- Asiste a guardería ("salita")

CASO CLÍNICO SIMULADO — DEMOSTRACIÓN PEDIÁTRICA

ANÁLISIS CLÍNICO — AutaMedica IA

Cruces entre secciones

CRITICAL — Antecedente de internación por bronquiolitis + cuadro respiratorio actual con signos de dificultad respiratoria (tiraje, taquipnea). Historia de vulnerabilidad respiratoria. *Cruce: antecedentes personales × respiratorio*

CRITICAL — Madre administra ibuprofeno sin conocer la concentración ni la dosis correcta por peso. Riesgo de subdosificación (tratamiento ineficaz) o sobredosificación (toxicidad). *Cruce: medicamentos × motivo de consulta*

HIGH — Vacunación incompleta en contexto de enfermedad respiratoria febril aguda. Aumenta riesgo de enfermedades prevenibles. *Cruce: antecedentes personales × enfermedad actual*

HIGH — Otitis recurrente (3 episodios/año) + cuadro respiratorio actual + exposición a tabaquismo pasivo y humedad ambiental. Patrón de patología respiratoria recurrente con factores ambientales perpetuadores. *Cruce: hábitos × antecedentes personales × respiratorio*

MEDIUM — Contacto epidemiológico confirmado: 3-4 niños enfermos en guardería la semana previa + hermano de 1 año actualmente con catarro. *Cruce: clarificación × filiación*

Alertas de seguridad

Alerta	Relevancia
Signos de dificultad respiratoria (tiraje intercostal, taquipnea)	CRÍTICA
Letargia / cambio significativo en nivel de actividad basal	ALTA
Fiebre alta (hasta ~39°C referido)	ALTA
Vacunación incompleta	ALTA
Error potencial de medicación (dosis incierta, concentración desconocida)	ALTA
Antecedente de internación por bronquiolitis	ALTA
Tabaquismo pasivo + vivienda húmeda	ALTA

Manejo del lenguaje coloquial por AutaMedica IA

Lo que dijo la mamá	Traducción semiológica
"se le mueven las costillitas para adentro"	Tiraje intercostal referido por familiar
"tos fea como que le sale de adentro"	Tos profunda/productiva
"respira como rápido a veces"	Taquipnea referida
"está caído, no quiere jugar"	Letargia
"no quiere comer nada"	Inapetencia marcada
"39 y pico pero no me acuerdo bien"	Pico febril ~39°C (dato impreciso, se preserva)
"le doy como 3 mililitros creo"	Dosis incierta — concentración desconocida

Datos no interrogados

- Presencia de lágrimas al llanto (deshidratación)
- Humedad de mucosa oral
- Aleteo nasal o quejido espiratorio
- Características de la expectoración
- Marca y concentración del ibuprofeno administrado
- Cuantificación de ingesta líquida en 24hs

Confiabilidad del informante: Madre de 22 años, secundaria incompleta. Relato coloquial con datos imprecisos en dosificación y temperatura. Observaciones clínicas relevantes (tiraje) aportadas por la abuela. Datos de vacunación y antecedentes paternos referidos sin certeza.

Motor: Desarrollo interno AutaMedica | **Intervenciones:** 2 checkpoints + 3 preguntas

Documento confidencial — Ley 26.529 de Derechos del Paciente